

Narratiivteraapia kliinilises ja rakenduslikus sotsiaaltöös

positiivse kehakuvandi kujunemise näitel teismelistel ja noorukitel



Davide Ticchi

Sotsiaaltöö doktorant, Tallinna Ülikool

Artikkel annab ülevaate narratiivteraapia teoreetilistest alustest ja selle meetodi kasutamist seoses kehakuvandi¹ kujunemisega teisme- ja noorukieas. See on kirjutatud sooviga aidata kaasa teooria ja praktika lõimimisele kliinilises ja rakenduslikus sotsiaaltöös. Ülevaade põhineb narratiivteraapia kasutamise juhistel ja kirjandusallikatel, ühtlasi on artiklis kirjeldatu ka minu doktoriõpingute teema².

Tutvustan analüüsi aluseks olevat teaduskirjandust ja materjale narratiivteraapia kohta, alustades selle poststrukturealistliku teraapiameetodi kõige üldisemast raamistikust ning liikudes kitsamate kehakuvandit puudutavate alateemadeni. Narratiivteraapia põhimõtteid saab kasutada nii töös inimestega, kellel on moonutatud arvamus oma välimusest (nn keha düsmorfiline häire) kui ka näiteks kaasasündinud rindkere moonutusega inimeste puhul: mõlemal juhul võib tulla

kõne alla kas kirurgiline või mittekirurgiline korrektsioon. Jättes kõrvale meditsiinilised sekkumised, analüüsin oma uurimistöös nii kirjandusest pärinevaid kui ka teraapia eri osapooltelt (noorukid ise, nende pered, terapeudid ja arstid) kogutud andmeid selle kohta, kuidas narratiivteraapia soodustab positiivse kehakuvandi kujunemist teismelistel ja noorukitel, võttes arvesse ka teraapias osalevate noorte sotsiaalkultuurilist konteksti. Kuna narratiivteraapia põhimõtteid saab kasutada igasuguse nõustamise puhul, siis pakuvad artikli järeldused huvi lugejatele, kes soovivad rohkem teada saada sellest lähemisviisist ja selle kasutamise võimalustest rakenduslikus sotsiaaltöös.

Narratiivteraapia lähtekohad

1989. aastal võtsid Uus-Meremaa terapeut David Epston ja Austraalia sotsiaaltöötaja ning pereterapeut Michael White kasutusele

¹ Inimese subjektiivne kujutus oma välimusest. Kehakuvand kujuneb nii iseennast kui teiste reaktsioone jälgides www.merriam-webster.com/medical/body%20image – toim.

² Davide Ticchi doktoritöö teema on „Narratiivne psühhoterapia häiritud kehakuvandiga teismelistele ja noortele: alternatiivne ja toetav meetod korrektiivsele kirurgiale”. Uurimuse andmeid kogutakse narratiivse psühhoterapia seansside käigus. Uuringus osalevad rindkere seinade deformatsiooniga patsiendid Tallinna Lastehaigla ja Genoa Gaslini Lastehaigla (Itaalia) lastekirurgia osakondadest. Lisaks kaasatakse uuringus osalema noorsportlased, et anda uurimuse tulemustele laiem tähendus nende kehakuvandit puudutavate isiklike lugude kaudu. Davide Ticchi juhendaja on prof Merike Sisask (Tallinna Ülikool, ühiskonnateaduste instituut) ja konsultandid dr Tiit Härma (Tallinna Lastehaigla) ning dr Michele Torre (Genoa Gaslini Lastehaigla).

kirjeldava eesliite *narratiiv*, et tähistada uut teraapiameetodit – narratiivteraapiat. See tõi endaga kaasa läbimurde peavoolu psühholoogias: kuni selle hetkeni kujutasid psühholoogia teooriad inimesi „mitte ainult piiratud, vaid lausa eksitavatel viisidel ... Kas keegi on üldse täheldanud, et käitumine *ei ole* tegelikult pelgalt instinktiivse energia vabastamine ega varasemast õpitu ja praeguste asjaolude koosmõju paratamatu tulemus või et tegelikult inimene ei ole pelgalt keegi, kes on maailmas olemas (ingl *being-in-the-world*). Loomulikult mitte.” (Ossario 1985, ptk 2). Narratiivteraapia autorite uskumuse kohaselt avaldavad inimese mõtlemisele ja käitumisele kõige suuremat mõju eeskätt sotsiaalkultuurilised tegurid. Seda mõju tuleb osata märgata, uurida ja aidata inimesel vajaduse korral sellest vabaneda. (Payne 2006, 32)

Samaaegselt leidis 1970.–80. aastatel aset sotsiaal- ja käitumisteaduste postmodernne revolutsioon, mille tulemusel lisandus aina uusi seletusi ja vaatenurki inimekäitumisele, mis avaldus ka psühholoogias. Mitmed sotsiaalteadlased hakkasid kaaluma, kas tasuks uuesti kasutusele võtta narratiivteraapiaga sarnanev mitteakadeemiline lähenemine inimestele ja nende omavahelistele suhetele, mida Ameerika psühholoog Jerome Bruner nimetas „tavapsühholoogiaks” (Bruner 1990). Sõltumatu terapeut ja koolitaja Martin Payne märgib oma narratiivteraapia juhiste teises väljaandes (2006, 179), et tavapsühholoogial on mitmeid põhimõtteid ja väärtusi, mis seovad seda narratiivteraapiaga, näiteks:

- Inimese teadlikke ja väljaöeldud kavatsusi, eesmärgi ja väärtusi tuleb võtta tõsiselt.
- Inimest tuleb näha oma elu peaosalisena: olenemata segastest tunnetest, mureddest ja ebakindlusest on iga inimene võimeline täiel määral mõistma iseennast ja teisi, ta teab oma valikute põhjusi ja kannab oma uued vaatenurgad üle tegudesse.

- Sügavamõtteliste metafooride kasutamine ei anna psüühika toimimise kirjeldamisele midagi juurde.
- Erakordsetele sündmustele tuleb anda arusaadav tähendus, tõlgendades neid igapäevaelust tuttavate normide kaudu.
- Tavapsühholoogias väljendatakse oma vaadet maailmale, elule ja suhetele narratiivide kaudu.

Samas toob Payne (2006, 179) välja, viidates White’ile, Brunerile ning Suurbritannia sotsioloog Richard Hoggartile, et sotsioloogias, sotsiaaltöös ja psühholoogias „ei tohiks suhtuda tavapsühholoogiasse liialt sentimentaalselt ... See koosneb erinevatest elementidest ja on sama mitmetahuline nagu iga teinegi diskursus, olles seejuures vastuvõtlik eelarvamustele nagu iga teine eluvaade. Seda lähenemist saab aga analüüsida, küsimuse alla seada ja vaidlustada, kasutades kõigile ühiselt arusaadavaid viise, mis *ei eelda vaidlustajalt erialaseid psühholoogilisi teadmisi*.”

Oma kriitilise hoiakuga „erialaste psühholoogiliste teadmiste” suhtes soovivad kolm eelmainitud teadlast viidata peavoolu psühholoogiale omasele internaliseeritud ehk inimesele omistatud ja tema poolt omaks võetud probleemi käsitlesele. Kuulus prantsuse sotsiaalteadlane Michel Foucault pidas subjektiveerimist ehk inimese tundmustest lähtumist esimeseks sammuks selle poole, et spetsialistikesksetesse, nn professionaalsetesse ja probleeme omistavatesse teraapiaviisidesse kaasatud inimesi hakataks vähem kohtlema passiivsete, piiratud võimalustega objektidena. Foucault arvates juhivad ja jälgivad inimesed oma käitumist, lähtudes isiklikest tõlgendustest kindlaksmääratud kultuurilistele normidele ning samaaegselt otsivad nad väliseid autoriteete nagu religioossed juhid või psühhoanalüütikud, kes neid täiendavalt juhendaksid (Foucault 1983 ja 1994). Pereterapeut Stephen Madigani

Narratiivteraapia põhimõtted

Narratiivteraapia käsitleb inimest kui oma elu peamist eksperti, see on osa uuest liikumisest, mis on hakanud mõjutama vahetut sotsiaaltöö praktikat sellega, et seab küsimuse alla sotsiaaltöö tavapärase raamistikud ja lähtekohad ning rõhutab *lugude, narratiivide* ja *diskursuste* olemuslikku võimu (Dulwich Centre, i.a; Paquin 2009). Narratiivses lähenemises vaadeldakse probleeme inimesest eraldiseisvatena ning eeldatakse, et inimesel on palju oskusi, võimeid, väärtusi, kohustusi, uskumusi ja pädevusi, mis aitavad tal muuta suhtumist tema elu mõjutavatesse probleemidesse (Narrative Therapy..., i.a). Sellele lähenemisele omane väiksem sotsiaaltöötaja ekspertteadmiste rõhutamine ning kliendi tundmise ja temaga töötamise oskuse tähtsustamine sobib hästi kokku multikultuurilise ja feministliku sotsiaaltöö põhimõtetega, kus tuntakse muret imperialistlike ja patriarhaalsete mõjude üle sotsiaaltöös (Paquin 2009).

Payne (2006, 5) selgitab narratiivteraapia kohta teiste teraapiavormide hulgas järgmiselt: „*Isikukesked* nõustajad jagavad narratiivterapeutidega ühist seisukohta selles, et mõlemad teraapiavormid aitavad inimestel paremini teadvustada olemasolevaid eluks vajalikke teadmisi, oskusi ja võimeid ning kasutada neid oma elu muutmiseks. /.../ *Kognitiivseid* lähenemisi kasutavad nõustajad usuvad, et ebaloogiline mõtlemine on peamine tegur, mis takistab inimesel ületada praktilisi ja emotsionaalseid raskusi. /.../ *Psühhoanalüüsi* teoreetikud, näiteks Donald Spence, rõhutavad, et terapeutid ei tegele ja neil ei ole võimalikki tegeleda abi otsiva inimese töötlema ja tegeliku minevikukogemusega, vaid nad saavad töötada ainult selle terapeutilise materjaliga, mida inimene teda teraapiasse toonud põhjustena esitab. /.../ Narratiivterapeutid nõustuvad kõigi nende tähelepanekutega.”

(2011, 56) arvates on Foucault järeldused nende „kultuuriliselt loodud taevallike nõuannete ja ülekantavate tõlgenduste” tegeliku olemuse kohta äärmiselt olulised. Need toovad esile narratiivteraapias olulise põhimõtte, et tähendusi loob „domineeriv kultuuriline diskursus”.

Eelmainitu võis aidata panna aluse ausamale, performatiivsele eneseloomele, mis sünnib spetsialisti ja teraapias osaleva isiku koostöös. Performatiivse³ eneseloome all on mõeldud võimalust luua sügavam ja isiklikum lugu probleemist.

Kui me nõustume Foucault seisukohaga, et teraapia osalisi on võimatu paigutada „mis tahes tegevuse korral kultuurilisest kontekstist väljapoole”, kus on oma koht ka teraapiaprotsessis kaudselt osalevatel inimestel, siis me lõpuks vastandume Amedeo Giorgi teooriale, mille kohaselt ekspertteadmised asuvad justkui

väljaspool loomulikku maailma (Madigan 2011, Giorgi 1985). Kõike seda arvesse võttes püüab narratiivteraapia uurimise metodoloogiline raamistik hoiduda eri distsipliinide vastanduvatest käsitlustest, lõimides samaaegselt neid elemente, mis võimaldavad ületada piiravaid eeldusi kliinilises sotsiaaltöös, psühholoogias ja antropoloogias, nagu empaatiavõime või eneserefleksioon.

White'i „piiravate eelduste kolmik” ja narratiivteraapia põhimõtted

Narratiivteraapia üks loojatest Michael White on sõnastanud „piiravate eelduste kolmiku” ehk kolm peavoolu teraapias laialt levinud eeldust, mis on omavahel vastastikuselt seoses ja samas võimutsevad kogu nõustamiskultuuri üle. Kuna need tahes-tahtmata mõjutavad

³ Tuleneb sõnast *performance* – tegevuskunsti liik, milles kunstniku juhatusel (vahel ka publiku osalusel) luuakse (improvisatsiooniline) etendus – toim.

ka narratiivteraapiat kasutavat spetsialisti, siis on oluline olla nendest teadlik ja osata neid ära tunda.

Esimene piirav eeldus: tõe tahe

Poststrukturealismis ja sotsiaalkonstruktivismis ei küsita: „*Mis on tõe selle kohta, kes me oleme?*”, kuna „see, kes me oleme, on muutuv, mitte peidetud muutumatu väärtus, mida peab otsima ja kindlaks määrama ...” Poststrukturealistliku lähenemise kohaselt peaksime küsima: „Miks mõjutab meid ümbritsevale kultuurile omane teadmus ning tavad meie elu- ja mõtteviisi?” (White 1997, 223). White nimetab seda piiravat eeldust **tõe tahteks** (ingl *the will to truth*), mis kitsendab võimalusi keskenduda teraapias osalejate elukogemusele ja olukordlikele teadmistele. Seega viitab White ühemõtteliselt tavapsühholoogia seisukohtadele ja „inimese keha, mõtete ja käitumisega tehtavate toimingute” performatiivsele eneseloomele (Payne 2006, Foucault 1980)⁴.

Madigani kohaselt „hõlmavad need toimingud enesemõistmise protsessi sisemise dialoogi kaudu, milles kajastuvad välised kultuurinormid”. Sellega jõuab Madigan (1998, 19) narratiivteraapia ühe olulisema põhimõtte, milleks on eksternaliseerimine ehk probleemi lahutamine subjektist, mis võimaldab spetsialistidel ja isikutel:

- probleemi põhjalikumalt selgitada („Kas muretsemine on üldse häirinud sinu argielu?”)
- panna probleemile nimi („Kuidas võiksime seda probleemi nimetada?”)
- probleemi endast eraldama („See mõjutaski mind niiviisi käituma ja tundma”)

- kasutada kujundlikku keelt (öeldes pigem „Nii et sa oled alati kasutanud mõnda rituaalset tegevust, et saada juurde enesekindlust?”, mitte aga: „Nii et sul on sundmõtted ja -käitumine?”)
- analüüsida kultuurilist survet näha probleeme „seesmistena”
- tuua esile olukorrad, milles probleem ei avaldu.

Teine piirav eeldus: allasurumise hüpotees

Nimetatud võimalused avanevad terapeutiliste vestluste ja intervjuude käigus, kus terapeut kasutab eksternaliseerimist korduvalt, jäädes ise tahaplaanile⁵. See võimaldab inimesel jutustada ja taasjutustada üksikuid süzeeliine oma eluloost seni, kuni jutustaja teadvusesse tuuakse alguses üksikud juhtlõngad ja siis tervikpilt nn unikaalsetest olukordadest. Unikaalsed olukorrad, üks narratiivteraapia põhimõisteid, on erandid inimese jutustatud probleemiloos ehk sellised olukorrad, kus inimene tundis ennast probleemist vabana või tajus probleemi mõju oluliselt väiksemana. Näiteks oma keha häbenev teismeline tüdruk, kes ei julge minna randa, käib ometi saunas, kus ta tunneb ennast hästi. Eesmärk on asendada domineeriv probleemne lugu uuega, milles erandlikud olukorrad oleksid põimitud inimese tajutud eluloo põhiliini. White'i sõnastatud teise piirava eelduse – **allasurumise hüpoteesi** (ingl *the repressive hypothesis*) teadvustamine aitab meil mitte võtta iseenesest mõistetavatena allasuruvaid psühholoogilisi mehhanisme, seda ka kehakuvandi puhul (Payne 2006). Sõnastades ümber sellest lähenemisest tulenevaid üldlevinud

⁴ Foucault järgi on ühiskonnas terve hulk nn enesetehnikaid, „mis võimaldavad indiviididel endil teha oma kehaga, hingega, mõtete ja käitumisega teatav hulk toiminguid ning nõndaviisi ennast muuta ja kujundada...”, mis aga omakorda lähtuvad ühiskonnas domineerivatest diskursustest. – toim.

⁵ Sellist tehnikat kutsutakse terapeudi detsentraliseerimiseks – autor.

eeldusi White'i poolt väljatoodud viisil ja Foucault' seisukohti kokku võttes võib öelda (1997, kaldkiri on lisatud), et:

a) Kui ma surun endas alla *oma tõelised tunded oma keha suhtes*, siis varjab see minu eest minu tõelist loomust,

mistõttu

b) enda tõelise loomuse varjamine takistab või pidurdab minu arengut ja *enesekindla mina-identiteedi* avaldumist,

mistõttu

c) *enesekindla mina-identiteedi* arenemise ja kujunemise takistamine või pidurdamine toob endaga kaasa negatiivsuse selles, *kuidas ma end oma keha suhtes tunnen* ning toob kaasa pettumuse oma tõeliste vajaduste ja soovide suhtes.

Hälbinud mina-identiteedi nõiaring paneb inimest uskuma, et ta on allutatud mingile survele, mis takistab tal mõistmast, kuidas ta ennast oma keha suhtes tunneb. „Allasurutud” ja määratlemata süžeeleiniide avastamine oma eluloos narratiivi kaudu ühildub üldjoontes White'i nägemusega, et inimene peaks end vabaks laskma *oma kehasse suhtumise* piiravast eeldusest, mille kohaselt oma tundeid alla surudes inimene justkui varjab enda eest oma tõelist loomust, sest allasurumine on „mingi jõud, mis takistab tõe avastamist” (1997, 221). Lisaks osutab Austraalia narratiiviteraapia rajaja peavoolu psühholoogia eeldusele, et „allasurutus takistab meil saavutamast isiklikku õnne... See ei lase meil püüelda elu suunas, mis on meie loomusele omane”. Kui me sellest eeldusest lähtume, reprodutseerime lõpuks ikkagi ühiskonnas domineerivaid „õigesti olemise” viise või kehaideale, mis ei ole saavutatavad, ilma et me püüaksime muutuda või muuta oma keha (*ibid*). Veel hullem on see, et meie „tõeliste vajaduste ja soovide takistamine võib viia igasuguste haigusteni”, mis tugevdab

probleemse loo kinnistumist isiku üldise tajutud eluloo külge ning kinnistab kehakuvandiga seotud väliste sotsiaalsete väärtuste muutumist eneseteadvuse osaks, omistades inimesele korduvalt kehakuvandiga seotuid obsessiiv-kompulsiivseid häireid (*ibid*).

Kolmas piirav eeldus: vabastav narratiiv

Seetõttu isegi kõige vähemsekkuvamaid nõustamismeetodeid kasutavad praktikud ei teadvusta kolmandat piiravat eeldust, milleks on **vabastav narratiiv** (ingl *emancipation narrative*). Selle asemel et keskenduda inimese läbielatud traumaatilise kogemusest väljapoole jäävatele elu aspektidele, üritatakse inimeste eeldatavatele probleemide leida lahendusi universaalsete allasurutud inimvajaduste kaudu (Payne 2006). Peavoolu psühholoogias domineeriv käsitlus, mis rõhutab abistamissuhtes probleemi sise-omaksvõttu, paneb mõtlema sotsiaaltöö eetiliste alustele, mis erinevalt Maslow (1954) kirjeldatud kõigile inimestele ühisest vajaduste hierarhiast, püüab neid samu inimvajadusi osadeks lahutada, võimaldades inimesel anda oma tähendus läbielatud kogemusele. Seetõttu on oluline, et otsuse tegemise protsess, nt valik sõltuvusest loobumise meetodi osas, oleks vastavuses inimese üldise isikliku loo üksikasjadega, mille teadvustamine toimub „küsides endalt, kuidas me elame olevikus” selle asemel, et „liikuda oleviku piirangute juurest parema tuleviku poole, kus ilmnevad meie tõelised minad *ja kehad*” (Payne 2006, 163, kaldkiri on lisatud). Valdav humanistlik idee eneseteadvustamisest kui parimast viisist vabastada end rahuldumisest elementaarse ellujäämise ja tervena püsimisega, mis „paneab vabaduse poole püüdleval inimesel taasesitama meie kultuuri „tõdesid” identiteedi *ja keha* kohta” (White 1997, 224, kaldkiri on lisatud).

See seob kehakuvandit puudutavate probleemidega inimesed, kes tahavad oma stigmast vabaneda, „veelgi tugevamalt oma

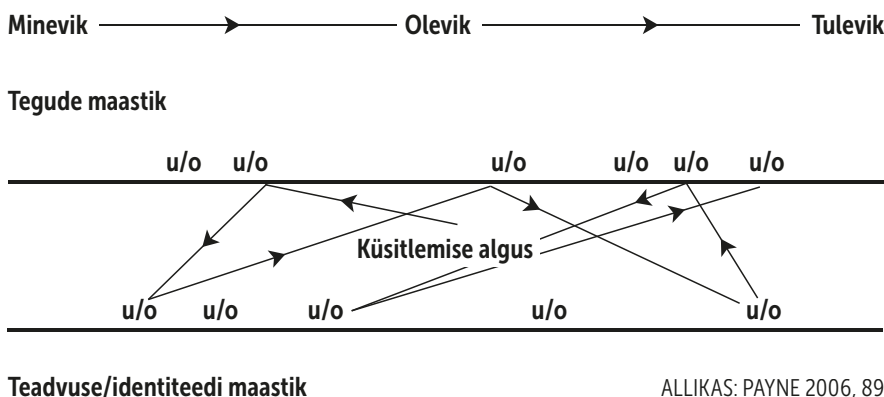
hinnangute subjektiivsuse külge”. See toob esile, et mitte „allasurumine” ise, vaid *hüpo-tees allasurumise kohta* varjutab asjaolu, et inimesi õhutatakse taaslooma kehakuvandi kohta käival „tõel” põhinevaid hinnanguid (*ibid*). Inimest pannakse uskuma, et tema subjektiivne hinnang oma välimusele ei ole „õige”, kui see liiga palju erineb ühiskonnas hea eluga seostatud kehaideaalist. Seetõttu on oluline vastanduda „omaks võetud seisukohtadele ja haigusi omistavatele uskumustele”, mis puudutavad näiteks elu kehalise moonutusega. Narratiivterapeut suunab inimesi uuele mõtteviisile oma probleemi defineerimisel. Selle asemel et määratleda „oma probleeme, lähtudes mineviku mõjutustest, mis on mind kahjustanud ja mistõttu mind peab ravima,” liigutakse probleemi konstruktiivsema tajumise suunas, mille kohaselt probleemi kohta käivat „ühte vaatepunkti, mille olen endale oma elu suhtes võtnud, saab kõrvutada kasulikumate ja kogemuslikumate vaatepunktidega.” (Payne 2006, 163). Kuigi see on keeruline nii spetsialistile kui ka teraapias osalevale isikule, on „võimuprobleemide äratundmine, hukkamõistmine ja nendega tegelemine võti, mis aitab inimesel saada selge ülevaate sellest, mida ta pidi läbi elama” ning mis aitab inimesel luua uut vaatepunkti,

mis ei keskendu nõrkustele, piinlikkusele ega kättesaamatutele mehelikkuse ja naiselikkuse ideaalidele (*ibid*, 164). Poststrukturealistliku ja sotsiaalkonstruksionistliku hoiakuga narratiivterapeutid ei tohi lähtuda oma mõtlemises White’i sõnastatud kolmest piiravast eeldusest.

Järelikult põhineb teraapia eetilistel valikutel, „mida ei ole võimalik teha, kui usume, et meis toimivad mitteisikulised ja meie tahte allumatud protsessid, näiteks surve...” treenida oma keha muskuliselt ühiskonnas, mis hindab lihaselisi mehi (*ibid*, 165).

See tähendab, et kui me terapeutidena oleme probleemide sisemise omaksvõtu vastu, siis peaksime pakkuma inimestele mõne teise toimiva meetodi, mis asendab arstipraktikale omast haigusele keskendumist. Joonisel 1 on kujutatud, miks kehakuvandi probleemidega tegelevad terapeutilised programmid peaksid lähtuma White’i tunnustatud siksakilisest küsitlusprotsessist (White 2004).

Rakendades sellist White’i juhistest lähtuvat üksteisele järgnevate küsimuste esitamise meetodit kehakuvandit puudutavate probleemide puhul, liigume tegude maastikult (mida sündmuses osalenud isikud selle kohta teavad, sellest mõtlevad, sellega seoses tunnevad või mida nad ei tea, ei mõtle ega tunne) edasi teadvuse tasapinnale (keskseks



ALLIKAS: PAYNE 2006, 89

Joonis 1. Küsitlusprotsessi ülesehitus ja käik (u/o = unikaalsed olukorrad)

isiku teadvus ja tema peegeldused sündmustest tegude maastikul), esitades seejuures küsimuse: „*Kui sa vaatad tagasi nendele sündmustele, mis sinu elus tookord aset leidsid, mida ütlevad need sulle selle kohta, mis sinu elus tegelikult oluline oli?*” Küsimuse võib esitada ka teistmoodi: „*Oskad sa nimetada ka mõnda muud sinu elus toimunud sündmust, mis peegeldaks sedasama uskumust selle kohta, mis on sinu jaoks oluline?*” (1995, 32). Lähtudes näidatud joone siksakilisusest, esitame küsimusi ka unikaalsete olukordade

kohta, mida nõustamise professor Donald Polkinghorne nimetab „vastastikku mõjutavaks protsessiks, mis leiab aset sündmuste endi ja neis läbijooksva ühise teema vahel, mis avab sündmuste olulisust, võimaldades neid käsitleda ühe loo eri osadena” (1988, 19–20).

Seega võib öelda, et kui me tähtsustame narratiivi väärtust inimeste elus ka teist tüüpi nõustamisprotsesside puhul, annab see praktikutele ja inimestele parema ja vahetuma ettekujutuse kliinilise sotsiaaltöö praktikast (Goldstein jt 2009). S

Tõlge inglise keelest: Anna-Kristina Rätsep / Tiido ja Partnerid Keeleagentuur / ajakiri Sotsiaaltöö

Viidatud allikad

- Bruner, J.** (1990). *Acts of Meaning*. Cambridge: Harvard University Press.
- Dulwich Centre** (*i.a*) What is narrative therapy? <http://dulwichcentre.com.au/what-is-narrative-therapy/> (05.05.2016).
- Foucault, M.** (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and writings*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M.** (1983). *The Subject and Power*. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago: University of Chicago Press.
- Foucault, M.** (1994). On the genealogy of ethics: An overview of work in progress. Teoses: Foucault, M. *Ethics: Subjectivity and truth: Vol. 1. Essential works of Foucault 1954–1984*. London: Penguin Press.
- Giorgi, A.** (1985). *Phenomenological and Psychological Research*. Pittsburgh: Duquesne University Press.
- Goldstein, E. G., Michls, D., Ringel, S.** (2009). *Advanced Clinical Social Work Practice – Relational Principles and Techniques*. New York: Columbia University Press.
- Madigan, S.** (1998). Practice interpretations of Michel Foucault. Teoses: Madigan, S., Law, I. (toim.). *Praxis: Situating discourse, feminism and politics in narrative therapies*, Vancouver: Cardigan Press. 15–34.
- Madigan, S.** (2011). *Narrative Therapy*. Washington: American Psychological Association.
- Maslow, A. A.** (1954). *Motivation and Personality*. New York: Harper and Row.
- Ossario, P.** (1985). An overview of descriptive psychology. Teoses: Gergen, K. J., Davis, K. E (toim.) *The Social Construction of the Person*. New York: Springer Verlag.
- Paquin, G. W.** (2009). *Clinical social work: A narrative approach*. Alexandria, VA, Council of Social Work Education, Inc.
- Payne, M.** (2006). *Narrative Therapy: An Introduction for Counsellors (2nd Ed.)*. London: SAGE Publications.
- Polkinghorne, D.** (1988). *Narrative Knowing and the Human Sciences*. New York: State University Press.
- White, M.** (1995). *Re-authoring Lives: Interviews and Essays*. Adelaide: Dulwich Centre Publications.
- White, M.** (1997). *Narratives of Therapist's Lives*. Adelaide: Dulwich Centre Publications.
- White, M.** (2004). Working with people who are suffering the consequences of multiple trauma: A Narrative Perspective. *International Journal of Narrative Therapy and Community Work*, (1), 45–76.
- Narrative therapy centre of Toronto** (*i.a*) About Narrative Therapy. <http://www.narrativetherapycentre.com/narrative.html> (05.05.2016).